UNIVERSITÉ PRIVÉE DE MARRAKECH UNIVERSITÉ **RECONNUE PAR L'ÉTAT** جامعة معترف بها من طرف الدولة	**Année universitaire :** 2023-2024 **Niveau : 4ème année** **Examens Session Normale (Juin 2024)**	FPMM FACULTÉ PRIVÉE DE MÉDECINE DE MARRAKECH
Semestre : S8	**Module : Appareil locomoteur** **Durée : 01 Heure** **Enseignant : Pr. Niamane (Coordinateur)**	

TRAUMATO-ORTHOPEDIE : 1 à 20 – RHUMATOLOGIE : 21 à 40 - MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION : 41 à 50.

1. L'atteinte des parties molles lors d'une fracture ouverte de jambe est évaluée selon la classification de :
A. Castaing
B. Marion lagrange
C. Merle d'aubigné
D. Cauchoix et Duparc
E. Aucune réponse juste

2. La rupture tendineuse survient lorsque l'étirement :
A. Est supérieur à 2%
B. Est compris entre 2% et 4%
C. Est compris entre 4% et 8%
D. Est supérieur à 8%
E. Aucune réponse juste

3. La fracture de Hoffa :
A. Est une fracture du radius distal
B. Est une fracture unicondylienne du fémur distal
C. Est une fracture à trait frontal
D. Est une fracture de la palette humérale
E. Passe souvent inaperçue sur une radiographie du genou de face

4. Parmi ces tests lesquels explorent les lésions méniscales :
A. Le test de Skinner
B. Le scotch test
C. Le grinding test d'Appley
D. Le test de NEER
E. Le test de Brunet Guedj

5. La fracture de Maisonneuve associe :
A. Une fracture du tibia à une fracture du tarse
B. Une fracture de la malléole interne à une fracture proximale de la fibula
C. Une fracture de la malléole externe à une fracture proximale du tibia
D. Une fracture de la cheville à une fracture du fémur
E. Aucune réponse juste

6. **La présence d'un trait de fracture vertical sur la malléole médiale et horizontal sous ligamentaire sur la malléole latérale au cours d'une fracture bimalléolaire présume que le mécanisme est en :**
A. Adduction
B. Abduction
C. Flexion plantaire
D. Flexion dorsale
E. Aucune réponse juste

7. Les signes de gravité d'une lésion musculaire sont :

A. La perception d'un craquement
B. L'impotence fonctionnelle totale objective et immédiate
C. L'installation retardée de l'œdème
D. La reprise rapide du sport
E. Aucune réponse juste

8. Devant une luxation du genou il faut rechercher impérativement :

A. Une lésion du nerf crural
B. Une fracture de hoffa
C. Une lésion de l'artère poplitée
D. Une rupture du tendon calcanéen
E. Aucune réponse n'est juste

9 - Parmi ces examens paracliniques, lequel est le plus sensible pour poser le diagnostic d'une fracture de fatigue :

A. Radiographie standard
B. Echographie
C. IRM
D. Arthrographie
E. Tomographie

10. Une des propositions suivantes ne correspond pas à la définition d'une tendinopathie :

A. Douleur à la palpation
B. Douleur à l'étirement
C. Palpation de nodule intra tendineux
D. Douleur à la contraction résistée
E. Aucune proposition juste

11 – L'avalement de la tubérosité tibiale antérieure du genou (recul de la TTA) témoigne de la lésion du :

A. Ligament poplité
B. Ligament latéral interne
C. Ligament croisé antéro latéral
D. Ligament croisé postéro médial
E. Aucune réponse juste

12. La présence d'un tiroir antérieur à l'examen clinique du genou témoigne d'une lésion du :

A. Ligament poplité
B. Ligament latéral interne
C. Ligament croisé antéro latéral
D. Ligament croisé postéro médial
E. Aucune réponse juste

13. Tous ces aspects évolutifs d'une tendinopathie sont possibles sauf un lequel ? :

A. La chronicité
B. La récidive
C. La dégénérescence maligne
D. La rupture
E. La calcification

14. Les moyens suivants font partie de l'arsenal thérapeutique des fractures de la patella sauf un lequel ? :

A. La genouillère plâtrée
B. Le cerclage
C. L'haubanage
D. L'ostéosynthèse par plaque vissée
E. La rééducation fonctionnelle

15. La lésion musculaire présentant des myofibrilles rompues et des aponévroses étirées correspond à :

A. Une contracture
B. Une élongation
C. Un claquage
D. Une déchirure
E. Aucune réponse juste

16. Les facteurs suivants favorisent la survenue de fractures de fatigue sauf un, lequel ? :

A. La race noire
B. Les troubles du cycle menstruel
C. Le changement de chaussure
D. Le changement de sport
E. L'activité répétitive

17. Les fractures du massif trochantérien engagent le pronostic vital du patient de par (1 réponse juste):

A. Le caractère douloureux de ces fractures
B. Le caractère fréquemment ouvert de ces traumatismes
C. Le caractère très hémorragique de ces fractures
D. Les complications de décubitus
E. Aucune réponse juste

18. Les objectifs du traitement des fractures du massif trochantérien sont :

A. Verticaliser rapidement le patient
B. Sauver la vie du patient
C. Eviter les complications de ces fractures
D. Préconiser un alitement prolongé du patient
E. Aucune réponse juste

19. La déformation caractéristique de la fracture de Pouteau Colles est :

A. Main tombante en col de cygne
B. Déformation du poignet en dos de fourchette
C. Déformation en billonnette
D. Déformation en main botte radiale
E. Aucune réponse juste

20. L'aspect en toupie sur une radiographie du poignet de face évoque :

A. Une fracture du scaphoïde
B. Une fracture de gerard marchant
C. Une fracture de goyrand smith
D. Une luxation retro-lunaire du carpe
E. Aucune réponse juste

21. La ponction du genou chez un jeune patient ramène un liquide trouble, contenant 75000 globules blancs/mm3 et quelques Cocci Gram négatifs. Parmi les diagnostics suivants, lequel est à envisager ?

A. Arthrose
B. Arthrite septique à staphylocoque
C. Arthrite tuberculeuse
D. Une crise de goutte
E. Arthrite septique à gonocoque

22. Madame X a une coxite droite chronique depuis 9 mois. Le bilan est en faveur d'une infection articulaire. Quel est le germe habituellement responsable de ce tableau clinique ?

A. Le staphylocoque aureus.
B. La tuberculose.
C. Le pneumocoque.
D. Les bacilles gram négatif.
E. Le gonocoque.

23. Indiquer, parmi les germes suivants, celui qui est le plus fréquemment rencontrés dans les arthrites septiques à germes banals.

A. Pseudomonas
B. Staphylocoque
C. Escherichia coli
D. Streptocoque A
E. Entérocoque

24. Un patient âgé de 72 ans, consulte pour une monoarthrite aigue du genou gauche. L'analyse d'un liquide articulaire montre un taux de leucocytes à 50000/mm3, 80% de polynucléaires, présence de microcristaux de pyrophosphate de calcium. L'examen bactériologique est négatif. Quel est le diagnostic le plus probable ?

A. Poussé d'arthrose
B. Arthrite septique
C. Crise de goutte
D. Crise de chondrocalcinose
E. Polyarthrite rhumatoïde

25. Une articulation très déformée mais indolente (non douloureuse), est observée en cas de (une seule réponse) :

A. Gonarthrose.
B. Polyarthrite rhumatoïde.
C. Tabès.
D. Spondyloarthrite.
E. Arthrite septique.

26. La capsulite rétractile, est responsable du tableau clinique suivant :

A. Une épaule douloureuse simple.
B. Une épaule douloureuse raide.
C. Une épaule douloureuse pseudo-paralytique.
D. Une épaule douloureuse hyperalgique.
E. Une épaule douloureuse instable.

27. Quelle est la localisation la plus commune de la première crise de goutte ?

A. Le genou
B. La cheville
C. Le gros orteil
D. Le coude
E. Le poignet

28. Parmi les règles hygiéno-diététiques au cours de la goutte, on cite :

A. Cure d'amaigrissement en cas d'obésité
B. Arrêt des boissons alcoolisées
C. Eviction des viandes rouges
D. Restrictions des apports hydriques
E. Alcalinisation des urines

29. La lésion le plus souvent trouvée à l'origine de l'hyperparathyroïdie primaire est :
A. Un cancer parathyroïdien
B. Un adénome bénin
C. Une hyperplasie des parathyroïdes
D. Une tumeur hypophysaire bénigne
E. Aucune des propositions

30. Le syndrome du canal carpien :
A. Est plus fréquent chez la femme.
B. Peut-être bilatéral.
C. Correspond à une compression du nerf cubital au canal de Guyon.
D. Est souvent idiopathique
E. Peut révéler une polyarthrite rhumatoïde.

31. A la phase précoce d'une algodystrophie du genou, les techniques d'imagerie montrent habituellement :
A. Une hyperfixation scintigraphique précoce.
B. Un pincement de l'interligne fémoro-tibial.
C. Une condensation osseuse.
D. Une déminéralisation mouchetée tardive.
E. Aucune des propositions.

32. La ténosynovite de Dequervain :
A. Est une ténosynovite des tendons du pouce.
B. Est réveillée par la manœuvre de Finkelstein.
C. Est localisée à la face interne du coude.
D. Intéresse les tendons fléchisseurs des doigts.
E. Se manifeste par un kyste synovial.

33. En cas d'ostéomalacie par carence en vitamine D:
A. La calcémie est normale ou basse.
B. La calciurie est basse.
C. La phosphorémie est élevée.
D. La phosphorémie est basse.
E. Les phosphatases alcalines sont basses.

34. La définition ostéodensitometrique de l'ostéoporose post ménopausique est :
A. Un T score > 2,5.
B. Un T score ≤- 2,5.
C. Un Z score > 2,5.
D. Un Z score < 2,5.
E. Un T score > 2.

35. Le méthotrexate est le traitement de fond de l'une des pathologies suivantes :
A. L'arthrose.
B. L'ostéomalacie.
C. La polyarthrite rhumatoïde.
D. La tendinopathie.
E. L'ostéoporose.

36. Le marqueur biologique le plus spécifique de la polyarthrite rhumatoïde est :
A. Le facteur rhumatoïde (Latex et Waaler-Rose).
B. Le HLA B27.
C. Les anticorps anti-peptides cycliques citrullinés.
D. L'examen cytologique du liquide articulaire.
E. Les anticorps anti-nucléaires

37. Les nodosités d'HEBERDEN et de BOUCHARD sont observées dans :

A. L'arthrose digitale.
B. L'arthrose lombaire.
C. La coxarthrose.
D. La gonarthrose.
E. L'arthrose cervicale.

38. La polyarthrite rhumatoïde au stade de début « PR débutante » est caractérisé par :

A. La facilité du diagnostic positif.
B. L'existence de nombreux diagnostics différentiels.
C. L'inefficacité du traitement
D. Des déformations typiques au niveau de la main.
E. La radiographie standard des mains est le plus souvent normale.

39. Dans le syndrome rachidien de la spondyloarthrite, on a les éléments suivants :

A. Une talalgie plantaire inflammatoire.
B. Une rachialgie cervicale inflammatoire
C. Une douleur mécanique de la paroi thoracique.
D. Une limitation de l'ampliation thoracique.
E. Une uvéite.

40. La radiculalgie symptomatique :

A. Est la forme la plus fréquente des radiculalgies.
B. Peut se voir dans l'arthrose du rachis
C. Peut se voir lors d'une hernie discale
D. Peut se voir dans une spondylodiscite
E. Peut se voir dans une SPA

Une patiente de 55 ans souffre de sa hanche, vous constatez, chez elle, une coxarthrose. (5 QCM)

41. Les déficiences possibles chez cette patiente sont :

A. La difficulté à aller à la mosquée
B. La difficulté à marcher
C. La difficulté à monter et descendre les escaliers
D. La douleur
E. La limitation articulaire

42. Les limitations d'activité possibles chez cette patiente sont :

A. La difficulté à aller à la mosquée
B. La difficulté à faire ces courses
C. La difficulté à marcher
D. La difficulté à monter et descendre les escaliers
E. La difficulté à pratiquer du sport

43. Les restrictions de participation possible chez cette patiente sont :

A. La difficulté à faire ces courses
B. La difficulté à garder la position debout
C. La difficulté à promener son enfant
D. La limitation articulaire
E. La raideur articulaire

44. Pour complément de prise en charge, vous adresser cette patiente chez :
A. L'orthophoniste
B. L'orthoprothésiste
C. Le kinésithérapeute
D. Le podologue
E. Le psychologue

45. Les objectifs de rééducation chez cette patiente sont :
A. Amélioration de la communication
B. Amélioration de la fonction
C. Education à l'hygiène de vie
D. Lutte contre la douleur
E. Lutte contre les contractures musculaires

46. Le(s) professionnel(s) susceptible(s) de confectionner des orthèses du poignet sur mesure est(sont) :
A. L'orthophoniste
B. Le kinésithérapeute
C. Le podologue
D. L'ergothérapeute
E. L'orthoprothésiste

47. Les muscles les plus affectés par les lésions musculaires sont :
A. Adducteurs
B. Gastrocnémiens
C. Ischio-jambier
D. Moyen fessier
E. Quadriceps

48. Quels sont les trois R à respecter dans la prescription de l'activité physique :
A. Raisonnable
B. Raisonnée
C. Recommandée
D. Régulière
E. Renforcée

49. Parmi les propositions suivantes, lesquelles constituent un facteur de risque de lésion musculaire ?
A. Dopage
B. Erreurs diététiques
C. Froid extrême
D. L'étirement musculaire
E. L'hyperhydratation

50. Cochez les éléments qui font partie de la triade classique des lésions musculaires :
A. Douleur à l'étirement
B. Douleur à la palpation
C. L'hématome
D. L'œdème
E. Les ecchymoses